Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

SENTENÇA

Vistos e examinados estes autos sob nº 0802747-84.2023.8.12.0029 de **AÇÃO Procedimento Comum Cível** em que é **Autor:** Laura Fernandes de Melo e **Réu:** Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Laura Fernandes de Melo, representada por sua genitora *Ana Fernandes de Melo*, qualificadas nos autos, move a presente **Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência** em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul,** também qualificados, dizendo, em resumo, que possui diagnóstico de diabete mellitus tipo 01 e, para seu tratamento, necessita de Insulina Tressiba 100ui/ml (20 unidades/dia). Afirma que não conseguiu obter o medicamento na rede pública de saúde e que ele é indispensável ao seu tratamento, não lhe restando outra saída senão o ajuizamento da presente ação. Com base em tais fatos sucintos, objetiva a condenação dos Requeridos para que lhe forneçam o medicamento **Insulina Tressiba 100ui/ml** pelo tempo de que o requerente necessite para seu tratamento. Apresentou outros requerimentos. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/23.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico às fls. 27/41.

Tutela de urgência indeferida (fls. 42/45).

Citado, o Requerido Município de Naviraí em sua defesa (fls. 57/64) alegou, em suma, que o medicamento pleiteado não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, de modo que deve ser observados para o seu fornecimento os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ.

Já o Requerido Estado de Mato Grosso do Sul na contestação ofertada (fls. 84/97), em síntese, discorreu pela necessidade de cadastramento prévio da paciente no PCDT, bem como pela inclusão da União no polo passivo, a qual detém responsabilidade pelo fornecimento de medicamento não incorporado nos protocolos do SUS.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (fls. 105/109).

Na fase de especificação de provas, os Requeridos pugnaram pelo julgamento antecipado do feito (fls. 136 e 137).

O Requerido Estado de Mato Grosso do Sul efetivou depósito na conta do Tribunal de Justiça para aquisição do medicamento para 06 meses de tratamento (fls. 154).

Conforme determinado às fls. 157, foi emitido alvará na conta da Autora no valor referente à 3 meses de tratamento. Prestação de contas pela parte Autora às fls. 168.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/04/2024 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802747-84.2023.8.12.0029 e código 5I5HCMof.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

O Município de Naviraí informou o fornecimento do medicamento à Autora às fls. 174.

Às fls. 160/282 foi juntado ofício referente ao Agravo de Instrumento n. 1421473-47.2023.8.12.0000.

É o relatório no essencial.

Decido.

Inclusão da União e Competência da Justiça Federal

O Estado de Mato Grosso do Sul pede a inclusão da União no polo passivo desta ação, afirmando que, de acordo com a tese firmada pelo STF sob o tema 793, há a necessidade de o juízo direcionar o cumprimento da obrigação a um dos entes federados demandados. No caso, por se tratar de medicamento não padronizado, a obrigação seria da União.

A questão é objeto do Tema 1234 no STF, ainda não julgado:

> *Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.*

A questão será decidida com repercussão geral no recurso representativo da controvérsia RE 1366243.

Enquanto não realizado o julgamento, o STF determinou que sejam observadas as orientações do STJ no IAC n. 14. Conforme informações obtidas em "precedentes qualificados" no site do STJ:

> "**Em 19/4/2023 o Tribunal Pleno do STF**, referendou decisão liminar proferida em 17/4/2023 no RE 1366243 (Tema de RG 1234), relator Ministro Gilmar Mendes, na qual foi condedido parcialmente pedido formulado em tutela provisória incidental no referido recurso extraordinário para estabelecer que, **'até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:** (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) **nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados**: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/04/2024 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802747-84.2023.8.12.0029 e código 5I5HCMof.

(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário'." - negritei

Desse modo, tratando-se de pedido de medicação não incorporada no SUS e de demanda ainda não sentenciada, deve ser mantida a tramitação perante a Justiça Estadual, opção eleita pela parte autora, sem inclusão da União, nem deslocamento de competência, aguardando-se a definição da questão no Tema 1234 do STF.

Mérito

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas, o que, aliás, não foi requerido por nenhuma das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Por sua vez, a Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º quec *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"*. E, no artigo 7.º, que:

> "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde − SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I − universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II − integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; IX − descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, <u>independentemente da condição financeira,</u> à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito integrador ao texto constitucional, seriam até desnecessárias se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade. O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado por entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/04/2024 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802747-84.2023.8.12.0029 e código 5I5HCMof.

firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

A edição da Lei nº 12.401/2011, em que pese sua importância e necessidade de respeito, não pode implicar em preterimento dos direitos do cidadão. A lei deve respeito à Constituição Federal e o Poder Judiciário é o garante das promessas do constituinte. Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior. Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Já é sedimentado o entendimento de que, se beneficiar o paciente, o médico pode utilizar um medicamento para finalidades diversas das indicadas, mesmo que em fase experimental. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).*

Desse modo, é patente a responsabilidade dos réus quanto ao atendimento das demandas relacionadas à saúde, o que, de resto, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 793, que estabeleceu a seguinte tese:

> Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, **compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento** conforme as regras de repartição de competências **e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro**. (Grifei)

Portanto, os requeridos não podem se esquivar do cumprimento da obrigação, embora caiba ao juiz estabelecer, caso a caso, qual ente federativo deverá cumpri-la com prioridade.

Demonstrada a responsabilidade dos requeridos, verifico que, no caso, a parte autora demonstrou que possui uma demanda na área da saúde e que não conseguiu dos requeridos, administrativamente, o medicamento de que necessita.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/04/2024 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802747-84.2023.8.12.0029 e código 5I5HCMof.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Neste passo, cumpre destacar que, apesar da insulina Degludeca (análogo de ação prolongada) não estar padronizada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais com este nome, conforme o parecer do NAT, a rede pública de saúde tem padronizadas na RENAME as insulinas de longa e rápida duração, que possuem o mesmo princípio ativo das insulinas prescritas à Autora.

Outrossim, para medicamentos que não estão padronizados pelo SUS, em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Resp 1.657.156, deve ser demonstrado o preenchimento dos seguintes requisitos: *a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanatária – ANVISA.*

Portanto, ainda que desnecessária a aplicação do Tema 106/STJ ao caso, tem-se o preenchimento de todos os requisitos para o fornecimento do medicamento, visto que o remédio pretendido possui registro na ANVISA (fls. 38, item IV), que a Requerente trata-se de pessoa hipossuficiente, já que se encontra assistida pela Defensoria Pública e afirma tal condição às fls. 12, bem como comprovou, por meio do laudo médico de fls. 18, que necessita do medicamento, pois já fez uso de outras insulinas disponibilizadas pelo SUS, sem obter êxito, bem como que o não uso do fármaco poderia lhe acarretar cegueira total, falência renal progressiva, até a necessidade de hemodiálise, entre outras graves consequências, como se vê no trecho do referido relatório médico abaixo:

Declaro para fins de esclarecimentos, que a paciente Laura Fernandes de Melo é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, insulino-dependente crônica, desde 2020. A paciente já fez tratamento com as insulinas NPH e Lispro, porém sem sucesso ao tratamento; evoluindo com episódios de hipoglicemias, alternadas com hiperglicemias, que são deletérias ao sistema nervoso central e ao sistema cardiovascular, com sequelas agudas e crônicas.

Atualmente tem apresentado controle adequado com o uso das insulinas Tressiba e Fiasp (conforme receituário), portanto recomendo que mantenha o uso continuo e urgente das mesmas. A paciente necessita da insulina Fiasp para manter o esquema terapêutico de contagem de carboidratos, a fim de melhorar o perfil metabólico e prevenir sequelas futuras e da insulina Tressiba como insulina basal de manutenção.

A troca por outras insulinas poderia acarretar riscos de descompensação do diabetes e suas complicações, inclusive risco de cetoacidose diabética, que pode causar a morte em horas.

As consequências do não controle do diabetes a médio e longo prazo incluem a cegueira total e irreversível, falência renal progressiva até a necessidade de hemodiálise, elevada incidência de infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral, gangrena dos membros inferiores entre outras complicações que acabam por determinar invalidez e morte precoce do(a) diabético(a) elevando assim o custo no tratamento da doença.

O controle glicêmico adequado, possibilita a redução significativa destas complicações. A paciente necessita das insulinas e insumos para controle adequado de seu diabetes. Solicito ainda os insumos necessários para os controles das glicemias (que são aferidos de 6 a 10 vezes ao dia) através do aparelho Freestyle – (laudo especifico em anexo) e agulhas para canetas de insulina (receita em anexo).

O bom controle do diabetes é a única alternativa para prevenir complicações com sequelas incapacitantes em pacientes portadores desta patologia. A paciente necessita das insulinas e insumos para controle adequado de seu diabetes.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/04/2024 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802747-84.2023.8.12.0029 e código 5I5HCMof.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

Por fim, quanto à exigência de cadastro no PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas), tem-se que o prévio cadastro configura-se como excesso de formalismo que não justifica a recusa da disponibilização do medicamento indispensável para o tratamento do problema de saúde da parte Autora, pois vai de encontro com o princípio da eficiência na prestação do serviço público.

Nesse sentido:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL – RESERVA DO POSSÍVEL – PREVALÊNCIA DO EFETIVO CUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. **EXIGÊNCIA DE CADASTRO NO PCDT (PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS) – FORMALIDADE EXCESSIVA.** HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento. A saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual deverá garantir à sociedade a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, **a exigência de cadastro do PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) como pressuposto à obtenção do fármaco, constitui formalidade excessiva que atua em detrimento do direito à saúde do indivíduo, ao passo que o cadastro pode ser providenciado pela Administração Pública no momento da entrega do medicamento.** Ausente o interesse recursal quando a sentença já se pronunciou favorável ao interesse do recorrente. (**TJMS.** Apelação Cível n. 0800870-93.2019.8.12.0015, Miranda, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 31/08/2022, p: 05/09/2022)

Portanto, por estas razões, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido que **Laura Fernandes de Melo** fez em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul**, qualificados, para o fim de determinar aos réus que forneçam por meio de seus órgãos executores competentes, à parte autora o medicamento **Insulina Tressiba 100ui/ml (insulina de ação prolongada), <u>pelo nome comercial ou princípio ativo</u>,** durante o tempo necessário ao seu tratamento, na quantidade que for solicitada para tanto pelo médico que a acompanha, mediante receituário, no prazo de 10 dias após a solicitação.

Deixo de fixar multa pelo descumprimento da obrigação, pois, segundo consta dos autos, o medicamento vem sendo fornecido (fls. 175/176) em razão do provimento do agravo de instrumento interposto pela parte Autora.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/04/2024 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802747-84.2023.8.12.0029 e código 5I5HCMof.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Em atenção ao Tema 793 do STF, deixo de direcionar o cumprimento da obrigação a um dos réus, pois, segundo informou o NAT, trata-se de fármaco adquirido pela União, que não compõe, neste momento, o polo passivo. Sendo assim, a obrigação não pode ser atribuída a nenhum dos requeridos, permanecendo a responsabilidade solidária entre os entes públicos demandados quanto ao cumprimento integral da obrigação.

Sem custas, *ex vi legis*.

Em vista do que restou decidido no Tema n. 1.002 do STF[1], condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, já considerado o grau de zelo do profissional, a importância e a natureza da causa, o tempo e o lugar da prestação do serviço. Ainda, com fulcro no art. 87, § 1º, do CPC, determino a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em 50% entre os litisconsortes passivos, ou seja, cada Requerido deverá arcar com a metade dos honorários fixados.

Com relação ao saldo referente ao valor depositado pelo Estado de Mato Grosso do Sul (fls. 165), considerando que foi efetuada a compra do medicamento equivalente a 3 meses de tratamento (fls. 168), bem como que o Município de Naviraí informou ter fornecido 3 unidades da insulina (fls. 175/176), **DETERMINO** a intimação da parte Autora para, no prazo de 5 dias, dizer se a obrigação de fornecimento está sendo atualmente cumprida e requerer aquilo que entender de direito, sob pena de devolução da quantia ao ente estatal demandado. Decorrendo o prazo ou não havendo interesse no levantamento da quantia, proceda-se com os atos necessários à devolução da importância ao Estado de Mato Grosso do Sul.

Declaro **extinto** o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame, pois não é certo o valor da condenação, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC e Súmula 490 do STJ.

Assim, decorrido o prazo recursal, mesmo sem oposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E. TJMS para reexame.

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

P.R.I.C.

Naviraí/MS, datado e assinado digitalmente.

---

[1] O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese vinculante no sentido de que "é devido o pagamento de *honorários* sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/04/2024 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802747-84.2023.8.12.0029 e código 5I5HCMof.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

Eduardo Magrinelli Júnior
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/04/2024 às 13:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802747-84.2023.8.12.0029 e código 5I5HCMof.